



COLLECTION « OLDY ET SÉBASTIEN »

Reconnaître l'invisible

*Comprendre et repérer
la dépression chez l'autre*

Sébastien TRIBET

Lundi 14 octobre 2014,

la vie a failli s'arrêter pour moi,
Sébastien TRIBET.

*J'ai du affronter des obstacles,
remonter la pentes,
pas seule mais accompagné.*

Alors toi qui est dans cette situation,
tu n'est pas seule.

Reconnaître l'invisible

Comprendre et repérer la dépression chez l'autre



Sébastien TRIBET

Collection « Oldy et Sébastien »

Reconnaître l'invisible

Comprendre et repérer la dépression chez l'autre

© 2026, TRIBET Sébastien. Tous droits réservés.

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur, conformément au Code de la propriété intellectuelle (articles L.122-4 et suivants).

Ouvrage de sensibilisation et d'entraide. Il ne se substitue en aucun cas à un avis ou à un suivi médical.

Cette œuvre est par ailleurs mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr>

Première édition – 2026. Dépôt légal : 2026.

Sommaire

1	Voir ce qui ne se voit pas	7
2	Tendre la main plutôt que pointer du doigt	15
3	Trouver les mots, et tenir dans la durée	21
4	Les visages multiples de la dépression	27
5	Comprendre pour mieux aider : la dépression sans tabou	33
6	Rendre visible l'invisible : ce que chacun peut faire	37

CHAPITRE

1

Voir ce qui ne se voit pas

Il existe des souffrances qui ne laissent aucune trace visible. Pas de plâtre, pas de béquille, pas de cicatrice que l'on pourrait montrer du doigt. La dépression est l'une d'elles. Une personne peut sourire le matin, répondre « ça va » au travail, plaisanter au repas du soir, et porter en elle, en silence, un poids qui l'épuise. C'est tout le paradoxe de cette maladie : elle se vit à l'intérieur, là où le regard des autres ne va pas spontanément.

Ce livre n'a pas pour but de faire de vous un médecin, ni de vous apprendre à poser un diagnostic — cela reste le travail des professionnels de santé. Son ambition est plus simple, et peut-être plus précieuse : vous aider à voir. À retrouver cette attention discrète qui permet de remarquer qu'un proche, un collègue, un voisin ne va pas bien, alors même que tout, en apparence, semble normal. Car reconnaître la souffrance de l'autre, c'est déjà tendre la main.

Avant d'apprendre à repérer les signes, il faut d'abord s'entendre sur ce dont on parle. Car le mot « dépression » est devenu si courant qu'il a fini par perdre son sens. On dit « je suis déprimé » pour une journée pluvieuse ou une déception passagère. La vraie dépression, elle, est tout autre chose.

La dépression n'est pas une simple tristesse

La tristesse est une émotion normale, humaine, nécessaire. Elle naît d'un événement précis — une perte, une déception, un échec — et elle s'estompe avec le temps. On peut être triste et continuer à rire d'une bonne blague, à savourer un bon repas, à se projeter dans demain. La tristesse traverse ; elle ne s'installe pas.

La dépression, elle, ne traverse pas : elle s'installe et colore tout. C'est un état durable qui s'étend sur les semaines, qui persiste souvent sans raison apparente, et qui éteint peu à peu le goût des choses. Là où la tristesse laisse intacte la capacité à ressentir du plaisir, la dépression assèche cette source elle-même. Les couleurs pâlisent, les saveurs disparaissent, l'élan vital s'épuise. La personne ne souffre pas seulement d'avoir mal : elle souffre de ne plus rien ressentir du tout.

Cette distinction est essentielle. On ne « sort » pas d'une dépression comme on sort d'un coup de cafard, par la volonté ou un week-end de repos. C'est précisément ce malentendu qui isole tant les personnes concernées.

Une maladie, pas une faiblesse

Il faut le dire clairement, et le répéter : la dépression est une maladie reconnue, au même titre que le diabète ou l'hypertension. Elle n'est ni un caprice, ni un manque de courage, ni une paresse de l'âme. Elle met en jeu des mécanismes biologiques du cerveau, une histoire de vie, parfois des facteurs héréditaires, souvent un enchaînement d'épreuves.

Dire à une personne déprimée « secoue-toi » ou « pense à ceux qui ont de vrais problèmes » revient à demander à quelqu'un avec une jambe cassée de courir un peu plus vite. Ce n'est pas une ques-

tion de volonté. Garder cela en tête change tout dans la façon dont on observe l'autre : on ne cherche plus une faille de caractère, on cherche les signes d'une souffrance réelle.

Les signes ne viennent jamais seuls

Un signe isolé ne veut rien dire. Tout le monde a des nuits sans sommeil, des journées sans entrain, des moments de doute. Ce qui doit attirer l'attention, c'est l'accumulation de plusieurs signes, leur durée dans le temps, et surtout la rupture avec ce qu'était la personne d'habitude. La dépression se lit comme une mosaïque : c'est l'ensemble, et non la pièce unique, qui dessine l'image.

On peut regrouper ces signaux en cinq grandes familles. Les voici, pour commencer à se familiariser avec eux ; les chapitres suivants entreront dans le détail de chacune.

Les signes émotionnels

- Une tristesse persistante, ou au contraire une sensation de vide, d'être « éteint ».
- Une perte de plaisir et d'intérêt pour des activités autrefois aimées (on parle d'anhédonie).
- Une irritabilité inhabituelle, des larmes faciles, ou une indifférence nouvelle.
- Une anxiété diffuse, une inquiétude qui ne se calme pas.

Les signes comportementaux

- Un retrait progressif : on décline les invitations, on ne répond plus aux messages.
- L'abandon de loisirs, de passions, de gestes du quotidien jusque-là évidents.
- Une négligence de soi : tenue, hygiène, repas pris au hasard ou sautés.
- Une baisse de régime au travail, des oublis, des retards inhabituels.

Les signes physiques

- Une fatigue qui ne cède pas au repos, une lourdeur permanente.
- Des troubles du sommeil : insomnies, réveils précoces, ou au contraire un besoin de dormir sans fin.
- Des changements d'appétit et de poids, dans un sens comme dans l'autre.
- Des douleurs diffuses, maux de tête, de dos ou de ventre sans cause médicale claire.
- Un ralentissement des gestes et de la parole, ou à l'inverse une agitation nerveuse.

Les signes cognitifs

- Des difficultés à se concentrer, à suivre une conversation, à lire.
- Une indécision inhabituelle, même pour de petits choix du quotidien.
- Des ruminations : les mêmes pensées sombres qui tournent en boucle.
- Un sentiment de dévalorisation, de culpabilité, d'inutilité.

Les mots qui doivent alerter

Parfois, ce ne sont pas les comportements mais les paroles qui livrent l'indice le plus clair. Certaines phrases, glissées en apparence sans gravité, méritent qu'on s'y arrête vraiment :

- « De toute façon, ça ne sert à rien. »
- « Je suis un poids pour tout le monde. »
- « Je n'en peux plus. »
- « Vous seriez mieux sans moi. »

Ces mots ne sont pas des formules en l'air. Ils sont, bien souvent, le seul appel au secours qu'une personne ose formuler. Ne jamais les balayer d'un « mais non, ne dis pas de bêtises » : les entendre, c'est déjà commencer à aider.

Ce qui fait la différence : durée, intensité, rupture

Pour ne pas confondre un coup de fatigue passager avec une vraie souffrance, trois repères sont utiles. La durée d'abord : on parle de

dépression lorsque les signes sont présents presque tous les jours, une grande partie de la journée, depuis au moins deux semaines. L'intensité ensuite : la souffrance gêne nettement la vie quotidienne, le travail, les relations. La rupture enfin : ce qui frappe, c'est l'écart avec la personne que l'on connaissait — quelqu'un de sociable qui s'isole, un passionné qui ne touche plus à ce qu'il aimait.

Souvent, la personne déprimée déploie une énergie considérable pour « faire semblant ». Le décalage entre cette façade et ce que vous percevez par instants — un regard absent, un soupir de trop, une phrase amère — est en lui-même un signal. La dépression se cache, mais elle laisse des indices à qui regarde avec attention et bienveillance.

Quand l'inquiétude devient urgence

Certains signaux ne peuvent jamais être ignorés. Lorsqu'une personne exprime un désespoir profond, le sentiment qu'il n'y a « aucune issue », qu'elle voudrait disparaître, ou qu'elle parle de la mort comme d'un soulagement, la situation devient une urgence. Un apaisement soudain et étrange après une période de grande détresse, le fait de donner ses affaires ou de « régler ses comptes », doivent aussi alerter.

Dans ces moments, le pire serait de rester seul face à son inquiétude. On ne sait pas toujours quoi dire, et ce n'est pas grave : l'essentiel est de ne pas laisser la personne seule et de l'orienter vers

une aide professionnelle. En France, des dispositifs existent, gratuits et accessibles à tout moment :

- Le 3114, numéro national de prévention du suicide, joignable 24 h/24 et 7 j/7, gratuitement, pour la personne en souffrance comme pour son entourage.
- Le 15 (SAMU) ou le 112 en cas d'urgence vitale immédiate.
- Le médecin traitant, qui reste un premier interlocuteur précieux pour amorcer un suivi.

Reconnaître les signes, ce n'est pas porter seul le poids de la situation. C'est savoir quand, et vers qui, se tourner.

À RETENIR

Apprendre à reconnaître la dépression chez l'autre, c'est avant tout réapprendre à regarder : dépasser le « ça va » de surface, prêter attention à l'accumulation des signes plutôt qu'à un détail isolé, et tenir compte de la durée et de la rupture avec l'habitude. C'est aussi se rappeler qu'il s'agit d'une maladie, non d'une faiblesse, et que certains mots ou comportements appellent une aide sans délai.

Dans les chapitres suivants, nous verrons comment ces signes s'expriment différemment selon les personnes et les âges, puis comment engager le dialogue avec justesse, et comment accompagner un proche sans s'épuiser soi-même. Mais tout commence ici, par ce premier geste de soin, le plus humble et le plus puissant : voir ce qui ne se voit pas.

CHAPITRE

2

Tendre la main plutôt que pointer du doigt

Il n'y a rien de plus facile au monde que de juger. Cela ne demande aucun effort, aucun courage, aucune connaissance. On regarde quelqu'un qui ne va pas bien, on hausse les épaules, et on tranche : « il se laisse aller », « elle se plaint pour rien », « il n'a qu'à se prendre en main ». En quelques mots, l'affaire est réglée — du moins pour celui qui juge. Pour l'autre, celui qui souffre, ces mots-là ne règlent rien : ils enfoncent.

Pourtant, il existe une autre voie. Plus exigeante, mais infiniment plus humaine : tendre la main. C'est le cœur de ce chapitre, et peut-être de tout ce livre. Car reconnaître la dépression chez quelqu'un ne sert à rien si c'est pour le condamner. Voir, c'est bien ; accompagner avec bienveillance, c'est tout.

Les mots qui enfoncent

« Secoue-toi. » « Pense à ceux qui ont de vrais problèmes. » « Tu te complais dans ta tristesse. » « Arrête de faire ta victime. » Ces phrases, on les prononce souvent sans méchanceté, parfois même en croyant aider. Mais pour une personne déprimée, elles tombent comme des coups.

Il faut comprendre une chose essentielle : la personne en dépression est déjà, intérieurement, son propre juge le plus sévère. Une petite voix lui répète sans relâche qu'elle ne vaut rien, qu'elle est un fardeau, qu'elle devrait s'en sortir seule. Quand un proche ajoute son propre jugement à cette voix intérieure, il ne fait que la confirmer. Chaque parole méprisante enfonce un peu plus la tête sous l'eau de quelqu'un qui lutte déjà pour respirer.

Le coup de pelle dans le dos

Lorsqu'une personne est déjà à terre, certains gestes ressemblent à un coup de pelle dans le dos. La moquerie, le « je te l'avais bien dit », le soupir agacé, le regard qui détourne — autant de manières de frapper quelqu'un qui ne peut plus se défendre. Nous le faisons parfois sans même nous en rendre compte, par impatience, par fatigue, ou simplement parce que la souffrance de l'autre nous met mal à l'aise et que nous préférons la repousser.

Mais l'effet, lui, est bien réel. À force de recevoir des coups là où il attendait du soutien, celui qui souffre apprend une chose terrible : se taire. Il cache, il fait semblant, il répond « ça va » pour ne plus s'exposer. Et c'est ainsi que la solitude s'installe, à côté de la maladie, comme une seconde souffrance.

Un service amical vaut mieux qu'un coup de pelle dans le dos

« Un geste amical vaut toujours mieux qu'un coup de pelle dans le dos. »

À l'inverse du jugement, il y a le geste tendu vers l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas besoin d'être grand. Inviter à boire un café. Envoyer un simple message : « je pense à toi ». Proposer une balade. Donner un coup de main pour une corvée que l'autre n'arrive plus à affronter. Ces petites attentions ne guérissent pas la dépression — ce n'est pas leur rôle — mais elles disent quelque chose d'immense : tu n'es pas seul, tu comptes pour moi.

La gentillesse ne coûte presque rien. Elle ne demande ni diplôme, ni grands discours, ni temps infini. Elle demande seulement de décider, dans un instant, de faire un pas vers l'autre plutôt que de se détourner. Et ce pas-là peut tout changer.

Prendre deux minutes

Ce que l'on offre de plus précieux à une personne en souffrance, ce n'est pas un conseil : c'est du temps. Prendre deux minutes pour s'arrêter, regarder l'autre dans les yeux et demander, sincèrement : « et toi, comment tu vas, vraiment ? » Puis se taire. Écouter. Laisser le silence faire son travail, sans se précipiter pour combler ou pour résoudre.

On croit souvent qu'il faut trouver les bons mots, la solution miracle, la phrase qui va tout débloquer. C'est faux. La plupart du temps, la personne n'attend pas qu'on règle son problème — elle attend d'être entendue sans être jugée. Écouter vraiment, c'est déjà soigner un peu. Deux minutes d'attention véritable peuvent être, pour quelqu'un au bord du découragement, une véritable bouée.

Le courage de tendre la main

Tendre la main demande du courage, et il faut le reconnaître honnêtement. On a peur de déranger, de mal s'y prendre, de dire une bêtise, de ne pas savoir quoi faire si l'autre s'effondre. Cette peur est normale. Mais elle ne doit pas avoir le dernier mot, car on ne regrette presque jamais une main tendue avec sincérité.

Et surtout : il n'est pas nécessaire d'avoir les mots parfaits. « Je ne sais pas quoi te dire, mais je suis là. » « Tu peux compter sur moi. » « Je reste près de toi. » Ces phrases simples valent mille fois mieux que le plus beau des discours. Ce qui blesse vraiment, ce n'est pas la maladresse de celui qui essaie : c'est le silence et l'absence de celui qui se détourne.

Ce qui blesse, ce qui aide

Pour s'y retrouver concrètement, voici quelques repères simples. D'abord, ces attitudes qui, même sans le vouloir, font du mal :

- Minimiser : « ce n'est rien », « ça va passer tout seul ».
- Comparer : « d'autres ont des problèmes bien pires ».
- Ordonner : « ressaisis-toi », « il faut positiver ».
- Juger : « tu te laisses aller », « tu en fais trop ».
- Fuir : changer de sujet, éviter la personne pour ne pas être mal à l'aise.

Et à l'inverse, ces gestes qui, eux, soutiennent vraiment :

- Écouter sans interrompre, en laissant à l'autre le temps de parler.
- Reconnaître la souffrance : « je vois que c'est dur en ce moment ».
- Proposer une présence concrète : un café, un appel, une promenade.
- Respecter le rythme de l'autre, sans le forcer ni le brusquer.
- Encourager doucement vers une aide professionnelle, sans l'imposer.

À RETENIR

Face à quelqu'un qui souffre, nous avons presque toujours le choix entre deux gestes : la pelle ou la main. Le premier ne demande rien et fait beaucoup de mal. Le second demande un peu de courage et peut faire un bien immense. Choisir la main ne sauve pas toujours, et personne ne peut porter à lui seul la souffrance d'un autre. Mais ce geste dit l'essentiel : « tu comptes, tu n'es pas seul. » Et parfois, c'est exactement cette phrase-là qui retient quelqu'un au bord du gouffre.

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment transformer cette bonne volonté en mots concrets : comment engager le dialogue, quoi dire et quoi éviter, et comment accompagner un proche dans la durée sans s'épuiser soi-même.

CHAPITRE

3

Trouver les mots, et tenir dans la durée

Vouloir aider est une chose ; savoir comment s'y prendre en est une autre. Beaucoup de gens, pleins de bonne volonté, restent sur le pas de la porte, paralysés par une question simple : « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? » Ils ont peur de mal faire, de réveiller la douleur, de prononcer la phrase de trop. Alors, souvent, ils ne disent rien — et c'est ce silence qui blesse le plus.

Ce chapitre est là pour vous rassurer : il n'existe pas de formule magique, et ce n'est pas grave. Aider quelqu'un qui traverse une dépression ne repose pas sur les mots parfaits, mais sur une présence sincère et patiente. Voyons ensemble comment ouvrir la conversation, comment écouter, comment orienter en douceur, et comment tenir sur la durée sans s'y épuiser.

Oser ouvrir la conversation

Le plus difficile est souvent le premier pas. Choisissez un moment calme, à l'abri du regard des autres et de la précipitation : une promenade, un trajet en voiture, un café partagé. Le côte-à-côte, où l'on n'est pas obligé de se regarder dans les yeux, facilite beaucoup les confidences.

Inutile de chercher une grande entrée en matière. Une phrase simple et honnête suffit : « Je te trouve un peu différent ces derniers temps, et je m'inquiète pour toi. Comment tu vas, vraiment ? » Le mot « vraiment » a son importance : il indique que vous ne vous contenterez pas du « ça va » automatique, et que vous êtes prêt à entendre la vraie réponse.

Quoi dire : reconnaître plutôt que résoudre

Une fois la porte entrouverte, le réflexe est de vouloir aider en proposant des solutions. C'est presque toujours une erreur. La personne n'attend pas qu'on règle sa vie, mais qu'on accueille ce qu'elle ressent. Les phrases les plus utiles sont celles qui reconnaissent la souffrance sans la juger :

- « Je vois que c'est vraiment difficile pour toi en ce moment. »
- « Tu n'as pas à traverser ça tout seul. »
- « Je ne comprends peut-être pas tout, mais je suis là, et je t'écoute. »
- « Merci de me faire confiance en m'en parlant. »

Ces mots ne cherchent pas à effacer la douleur — ils la rendent un peu plus supportable, parce qu'elle est enfin partagée.

Quoi éviter, même avec de bonnes intentions

Certaines phrases, dites pour réconforter, produisent l'effet inverse. Mieux vaut les connaître pour les éviter :

- « Tu n'as aucune raison d'être comme ça » — cela ajoute de la culpabilité à la souffrance.
- « Il suffit de te changer les idées » — la dépression n'est pas un manque d'occupation.
- « Moi aussi je suis fatigué, tu sais » — ramener à soi ferme la porte qui venait de s'ouvrir.
- « Tu verras, demain ça ira mieux » — une promesse que vous ne pouvez pas tenir.

Le point commun de ces phrases est qu'elles cherchent, au fond, à mettre fin à la conversation pour soulager celui qui écoute. Or l'enjeu est exactement l'inverse : laisser la conversation exister.

Écouter vraiment

« Écouter, ce n'est pas attendre son tour de parler. »

Écouter vraiment, c'est accepter le silence sans le combler aussitôt. C'est laisser l'autre chercher ses mots, quitte à ce qu'un long blanc s'installe. C'est aussi reformuler doucement ce qu'on a compris — « si je comprends bien, tu te sens épuisé même après avoir dormi » — pour montrer qu'on a réellement entendu. On n'écoute pas pour répondre ; on écoute pour comprendre. C'est l'une des plus belles formes de soutien que l'on puisse offrir, et elle ne demande aucune compétence particulière, seulement de la présence.

Quand l'autre se ferme

Il arrivera que la personne refuse de parler, nie aller mal, ou se braque. C'est fréquent, et ce n'est pas un échec. La dépression enferme, et la honte muselle. Dans ce cas, n'insistez pas, ne forcez pas la porte. Dites simplement : « Je comprends que tu n'aies pas envie d'en parler maintenant. Sache que la porte reste ouverte, quand tu voudras. » Puis laissez le temps faire. Le simple fait de savoir qu'une main reste tendue, disponible, sans pression, est déjà un appui précieux.

Orienter vers une aide, sans braquer

Votre rôle de proche est essentiel, mais il a une limite : vous n'êtes pas thérapeute, et vous n'avez pas à l'être. À un moment, il faut pouvoir suggérer une aide professionnelle, sans en faire une injonction. Présentez-la comme un appui supplémentaire, jamais comme un aveu de faiblesse :

- « Et si on en parlait à ton médecin ? Je peux t'accompagner si tu veux. »
- « Tu sais, en parler à quelqu'un dont c'est le métier, ça peut vraiment soulager. »

Le médecin traitant est souvent le meilleur premier interlocuteur. Et en cas de détresse profonde, rappelez l'existence du 3114, le numéro national de prévention du suicide, gratuit et joignable à toute heure, pour la personne comme pour vous.

Tenir dans la durée sans s'épuiser

Accompagner une personne en dépression n'est pas un sprint, c'est un marathon. La maladie peut durer des semaines, des mois, avec des hauts et des bas décourageants. Si vous donnez tout, tout de suite, vous risquez de vous épuiser et de finir par vous éloigner — au pire moment pour l'autre. Quelques repères pour durer :

- Vous n'êtes pas la seule bouée. Encouragez d'autres soutiens autour de la personne : famille, amis, professionnels.
- Posez vos limites sans culpabiliser. Avoir besoin de souffler ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais.
- Acceptez de ne pas pouvoir « réparer » l'autre. Votre présence compte, même quand rien ne semble s'améliorer.
- Prenez soin de vous aussi. On ne soutient bien que si l'on ne s'oublie pas soi-même.

Il n'y a aucune honte à dire, parfois : « là, j'ai besoin d'un peu de repos moi aussi. » Au contraire : c'est ce qui vous permettra de rester présent longtemps, vraiment.

À RETENIR

Aider quelqu'un ne demande pas les mots parfaits, mais une présence patiente : oser ouvrir la conversation au bon moment, reconnaître la souffrance plutôt que vouloir la résoudre, écouter sans combler les silences, et respecter le refus sans claquer la porte. Cela demande aussi de savoir orienter vers une aide professionnelle, et de ménager ses propres forces pour tenir dans la durée.

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces signes et ces gestes se déclinent selon les personnes : car on n'accompagne pas de la même façon un enfant, un adolescent, un adulte qui « tient » coûte que coûte, ou une personne âgée.

CHAPITRE

4

Les visages multiples de la dépression

La dépression n'a pas un seul visage. Elle parle une langue différente selon la personne, son âge, son histoire, son caractère. Les signes décrits au premier chapitre — la tristesse, la perte d'élan, le repli, la fatigue — restent vrais, mais ils se déguisent. Chez l'un, ils prennent le masque de la colère ; chez l'autre, celui de la douleur physique ou du silence. C'est pourquoi tant de dépressions passent inaperçues : on cherche un visage triste, et l'on passe à côté de toutes les autres formes qu'elle sait prendre.

Apprendre à reconnaître ces visages multiples, c'est élargir son regard. Voyons comment la dépression peut s'exprimer chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui « tient » coûte que coûte, et la personne âgée.

Chez l'enfant

On imagine mal qu'un enfant puisse être déprimé — et pourtant cela existe. À cet âge, la dépression ne se dit pas avec des mots ; elle se

montre par le corps et le comportement. Un enfant déprimé ne dira presque jamais « je suis triste ». Il faut donc regarder ailleurs :

- Une irritabilité nouvelle, des colères, des pleurs faciles plutôt qu'une tristesse visible.
- Des plaintes physiques répétées : mal au ventre, mal à la tête, surtout les matins d'école.
- Une perte d'intérêt pour les jeux et les activités qu'il aimait.
- Des difficultés à l'école, un repli, ou parfois un retour en arrière (énurésie, peur de la séparation).

Le maître mot reste le changement : un enfant habituellement vif qui s'éteint, ou un enfant calme qui devient ingérable, mérite qu'on s'y attarde avec douceur.

Chez l'adolescent

À l'adolescence, la frontière entre le mal-être passager et la dépression est particulièrement floue. On met beaucoup de choses sur le compte de la « crise d'ado » — et c'est précisément ce qui rend la dépression dangereuse à cet âge : on la banalise. L'adolescent dépri-

mé exprime rarement sa souffrance par la tristesse ; il l'exprime souvent par l'irritabilité, la révolte ou le retrait.

- Une humeur sombre ou explosive, des conflits à répétition, un repli dans la chambre.
- Une chute des résultats scolaires, un désintérêt soudain pour ce qui comptait.
- Un isolement des amis, parfois remplacé par un refuge dans les écrans.
- Des troubles du sommeil et de l'appétit, voire des conduites à risque.

Face à un adolescent, la pire attitude est de minimiser : « ça lui passera ». Le mal-être adolescent se prend au sérieux. Mieux vaut une inquiétude de trop qu'un signal ignoré.

Chez l'adulte qui « tient » coûte que coûte

« On peut sombrer en gardant le sourire. »

Voici sans doute le visage le plus trompeur. Certains adultes traversent une dépression tout en continuant à travailler, à assumer, à faire bonne figure. C'est ce qu'on appelle parfois la dépression « souriante » ou masquée. De l'extérieur, tout semble normal : la personne tient ses engagements, plaisante, rassure son entourage. À l'intérieur, elle s'épuise et se vide.

Ce visage concerne beaucoup d'hommes, à qui l'on a appris très tôt qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses. Plutôt que de dire leur souffrance, ils la détournent : irritabilité, surinvestissement dans le travail, prises de risque, consommation d'alcool, douleurs physiques

inexpliquées. Le danger du masque, c'est qu'il rassure tout le monde — y compris les proches — jusqu'au jour où il se fissure brutalement. Derrière un « tout va bien » trop parfait se cache parfois une détresse profonde.

Chez la personne âgée

La dépression de la personne âgée est l'une des plus fréquentes et des plus négligées. On la confond trop souvent avec la vieillesse elle-même : « c'est normal, à son âge, d'être fatigué et de moins sortir ». C'est une erreur. La vieillesse n'est pas synonyme de tristesse, et un repli marqué n'a rien d'inévitable.

- Une fatigue, un ralentissement, une perte d'intérêt mis à tort sur le compte de l'âge.
- Des troubles de la mémoire et de la concentration que l'on confond avec un début de démence.
- De nombreuses plaintes physiques, qui occupent le devant de la scène plus que la tristesse.
- Un isolement aggravé par les deuils, la perte d'autonomie, l'éloignement des proches.

La dépression de la personne âgée se soigne, comme celle des autres. Elle mérite la même attention — d'autant qu'elle est, chez les aînés, un facteur de souffrance trop souvent laissé dans l'ombre.

Un fil rouge à travers tous les visages

Quel que soit l'âge, un repère traverse toutes ces formes : la rupture avec ce que la personne était d'habitude. L'enfant qui s'éteint, l'ado-

lescent qui se révolte, l'adulte dont le sourire sonne faux, l'aîné qui se retire — tous racontent, à leur manière, un changement. La dépression se cache derrière mille visages, mais elle laisse toujours la même trace : quelqu'un n'est plus tout à fait lui-même. Apprendre à le remarquer, sans le réduire à « un caractère » ou à « un âge », c'est déjà ouvrir une porte vers l'aide.

À RETENIR

La dépression ne ressemble pas toujours à la tristesse : chez l'enfant elle se dit par le corps et la colère, chez l'adolescent elle se cache derrière la révolte, chez l'adulte elle se masque sous un sourire et une activité sans faille, chez la personne âgée on la confond avec le grand âge. Dans tous les cas, le signal le plus fiable reste le changement par rapport à l'habitude.

Dans le chapitre suivant, nous prendrons un peu de hauteur : qu'est-ce que la dépression, au fond ? D'où vient-elle, comment se soigne-t-elle, et pourquoi reste-t-elle, aujourd'hui encore, une maladie si entourée de silence ?

CHAPITRE

5

Comprendre pour mieux aider : la dépression sans tabou

Jusqu'ici, nous avons appris à reconnaître la dépression et à tendre la main. Prenons maintenant un peu de hauteur. Car pour aider sans juger, il faut comprendre ; et pour comprendre, il faut accepter de regarder cette maladie en face, telle qu'elle est, débarrassée des idées reçues. C'est aussi la meilleure arme contre le silence qui l'entoure encore.

Qu'est-ce que la dépression, au fond ?

La dépression n'est pas un coup de blues, ni une faiblesse de caractère, ni une humeur passagère. C'est une maladie à part entière, reconnue par la médecine, qui touche à la fois l'humeur, le corps et les pensées. Elle modifie la façon dont une personne ressent, dort, mange, se concentre et se perçoit elle-même. On ne « choisit » pas d'être déprimé, pas plus qu'on ne choisit d'attraper une grippe.

Et elle est loin d'être rare. La dépression touche des millions de personnes à travers le monde et figure, selon l'Organisation mondiale de la santé, parmi les premières causes de handicap. Au cours d'une vie, une part importante de la population y sera confrontée,

directement ou à travers un proche. Autrement dit : ce n'est ni hon-teux, ni exceptionnel. C'est une expérience profondément humaine.

D'où vient-elle ?

On cherche souvent « la » raison d'une dépression, comme s'il de-vait y avoir une cause unique et évidente. La réalité est plus nuan-cée : la dépression naît presque toujours de la rencontre de plusieurs facteurs.

- Des facteurs biologiques : un déséquilibre dans le fonctionne-ment du cerveau, parfois une part d'hérédité.
- Des facteurs psychologiques : une histoire personnelle, des blessures anciennes, certains traits de caractère.
- Des facteurs de vie : un deuil, une rupture, un surmenage, l'isolement, la précarité, une maladie.

Ces éléments s'entremêlent, et leur poids varie d'une personne à l'autre. Surtout, il faut le dire clairement : une dépression peut survenir sans raison apparente, alors que « tout va bien » en appa-rence. Cela ne la rend ni moins réelle, ni moins légitime. Reprocher à quelqu'un de souffrir « alors qu'il n'a aucune raison » est l'un des malentendus les plus douloureux.

Comment se soigne-t-elle ?

« La dépression se soigne — et l'on en guérit. »

Voici la nouvelle la plus importante de ce livre : la dépression est une maladie qui se soigne, et dont on guérit dans la grande majorité

des cas. Ce n'est pas une condamnation. Avec un accompagnement adapté, la lumière revient. Les soins reposent principalement sur :

- Un suivi psychologique : parler à un professionnel formé pour comprendre et dénouer ce qui pèse.
- Des traitements médicaux lorsqu'ils sont nécessaires, prescrits et suivis par un médecin.
- Un environnement soutenant : des proches présents, un rythme de vie ménagé, du lien social.

La guérison demande du temps et n'est pas une ligne droite : il y a des progrès, des rechutes, des paliers. Ce n'est pas un échec, c'est le chemin normal de la convalescence. Le rôle des proches n'est pas de soigner — cela revient aux professionnels — mais d'accompagner ce chemin avec patience et constance.

Pourquoi tant de silence ?

Si la dépression est si fréquente et si bien soignée, pourquoi en parle-t-on encore si peu ? Parce qu'une chape de silence pèse sur elle. Beaucoup de personnes n'osent pas dire qu'elles souffrent, par peur d'être jugées faibles, instables, ou « pas à la hauteur ». Elles craignent le regard des autres, les conséquences au travail, l'étiquette qui colle à la peau.

À ce poids s'ajoute le caractère invisible de la maladie. Comme on ne la voit pas, on doute de son existence — et la personne qui souffre finit elle-même par douter de sa propre douleur. Notre culture, qui valorise la force et la performance, fait le reste : « il faut être solide », « on ne se plaint pas ». Ce silence n'est pas neutre. Il isole, il retarde les soins, et il aggrave la souffrance. Se taire, dans le cas de la dépression, peut coûter très cher.

Briser le silence

C'est précisément là que chacun de nous a un rôle à jouer. Parler de la dépression simplement, comme on parlerait d'un autre problème de santé, c'est déjà fissurer le tabou. Chaque conversation honnête, chaque témoignage, chaque main tendue dit à ceux qui souffrent : tu n'es pas seul, tu n'as pas à avoir honte, et tu as le droit d'être aidé.

Rendre visible l'invisible, lui donner des mots, en faire un sujet que l'on peut aborder sans gêne : voilà peut-être la plus belle forme d'entraide. Car une maladie dont on peut parler est une maladie que l'on peut soigner.

À RETENIR

La dépression est une vraie maladie, fréquente, née de la rencontre de plusieurs facteurs, et qui peut survenir sans raison apparente. La bonne nouvelle est qu'elle se soigne et que l'on en guérit, à condition d'être accompagné, avec patience, sur un chemin qui n'est jamais tout droit. Si elle reste si entourée de silence, c'est à cause de la peur du jugement et de son caractère invisible — et c'est ce silence qu'il nous appartient, à tous, de briser.

Dans le dernier chapitre, nous verrons ce que chacun peut faire, à son échelle, pour rendre visible l'invisible et faire de notre entourage un lieu où la souffrance peut enfin se dire.

CHAPITRE

6

Rendre visible l'invisible : ce que chacun peut faire

Nous voici au terme de ce chemin. Nous avons appris à reconnaître la dépression derrière ses signes discrets, à préférer la main tendue au jugement, à trouver des mots simples et à tenir dans la durée, à comprendre cette maladie et à mesurer combien le silence l'aggrave. Reste une dernière question, peut-être la plus importante : que pouvons-nous faire, chacun, à notre échelle ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être médecin, ni psychologue, ni héros. Pour changer les choses, il suffit souvent d'être présent, attentif et humain. Et cela, tout le monde en est capable.

Commencer par changer notre regard

Le premier geste n'est pas tourné vers l'autre, mais vers nous-mêmes. C'est notre regard qu'il faut d'abord changer : remplacer le jugement par la curiosité, le « il exagère » par le « il souffre peut-être ». Choisir nos mots, aussi, car ils ont un poids. Cesser de dire « il est faible » ou « elle se laisse aller », et apprendre à parler de la dépression comme d'une maladie, simplement, sans gêne ni moquerie. Tout commence là, dans cette manière de voir et de nommer.

Des gestes simples, à la portée de tous

Au-delà du regard, il y a les gestes du quotidien. Aucun n'exige de compétence particulière, seulement un peu d'attention :

- Prendre des nouvelles, sincèrement : « et toi, comment tu vas, vraiment ? »
- Envoyer un message, passer un appel, à quelqu'un qu'on sent s'éloigner.
- Inviter, proposer une sortie, une marche, un café — sans forcer.
- Écouter sans juger, et reconnaître la souffrance plutôt que la minimiser.
- Accompagner vers une aide : proposer d'aller ensemble chez le médecin.
- Rester présent dans la durée, surtout quand l'amélioration tarde.

Pris isolément, ces gestes semblent minuscules. Mis bout à bout, ils tissent autour d'une personne fragile un filet qui peut la retenir.

Faire de notre entourage un lieu où la souffrance peut se dire

Chacun de nous appartient à des cercles — une famille, un voisinage, un lieu de travail, une association, un village. Dans chacun de ces cercles, nous pouvons contribuer à créer un climat où il devient possible de dire « je ne vais pas bien » sans craindre d'être jugé. Cela passe par de petites choses : ne pas se moquer, accueillir la parole de l'autre, oser parler soi-même de ses propres difficultés.

Quand une personne sait qu'autour d'elle, on peut parler de ces choses-là sans honte, elle ose se confier plus tôt — et plus tôt elle se confie, plus tôt elle peut être aidée. Faire de son entourage un espace sûr, c'est offrir à chacun la permission de ne pas aller bien, et donc la possibilité d'aller mieux.

Rendre visible l'invisible

« Une souffrance que l'on peut nommer est déjà une souffrance que l'on peut soulager. »

La dépression est une maladie invisible. Notre mission, à tous, est de la rendre visible : d'en parler, de l'expliquer, d'en faire un sujet ordinaire que l'on peut aborder à table, à l'école, au travail, entre amis. On peut le faire sérieusement, mais aussi avec créativité, avec douceur, avec des mots et des images accessibles à tous — car les sujets les plus lourds se laissent parfois mieux approcher par des chemins simples et lumineux.

Chaque fois que l'un de nous brise le silence, il allège un peu le poids que portent ceux qui souffrent. Chaque conversation honnête est une fissure dans le mur de la honte. Et c'est ainsi, geste après geste, parole après parole, que l'invisible finit par se voir.

Un dernier mot

Si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce livre, que ce soit celle-ci : face à quelqu'un qui souffre, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas à tout résoudre, ni à trouver les mots justes. Il vous suffit d'être là, de regarder vraiment, et de tendre la main. Ce

geste-là, à la portée de chacun, peut faire toute la différence — parfois même sauver une vie.

Merci d'avoir lu ce livre jusqu'au bout. En apprenant à reconnaître l'invisible, vous êtes déjà devenu, pour quelqu'un quelque part, une lumière possible.

Ressources utiles

Pour vous, ou pour aider un proche, gardez ces recours à portée de main :

- 3114 — Numéro national de prévention du suicide. Gratuit, 24 h/24 et 7 j/7, pour les personnes en souffrance comme pour leur entourage.
- 15 (SAMU) ou 112 — En cas d'urgence vitale immédiate.
- Le médecin traitant — Premier interlocuteur pour amorcer un suivi et orienter vers les soins adaptés.
- Les associations et lignes d'écoute locales, qui offrent soutien et orientation près de chez vous.

Note. Ce livre est un ouvrage de sensibilisation et d'entraide. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. En cas de souffrance importante ou de signaux d'alerte, n'hésitez jamais à demander de l'aide : ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage.

Le mot de l'auteur

Je souhaite juste apporté juste un petit mot pour toutes ces personnes qui n'ont pas comme moi réussit a trouver les bonnes personnes pour les aider a s'en sortir.

Beaucoup d'ami-e-is ont malheureusement fait un choix que je respect car quand on est dans cette situation et que tous le monde a soit disant toutes les réponses mais qui regardent la ou les personnes continuer a s ' enfoncer et qui connaissent tout mais aux fond ne savent réellement rien, même nous qui sommes passer par la nous sommes en incapacité d' expliquer pourquoi ? Comment ?

On peut apporter que quelque réponse que quand on y est passer, enfin je parle pour moi, car aujourd'hui je voit réellement les dégâts que j'ai causer et surtout comment ont me voit, et oui je suis l'alcoolique fénéant bon a rien qui ne connaît absolument rien , car oui je le dit haut et fort je n'est jamais rien eu de grave sauf que ce lundi 15 juin 2026, j' ai appris par ma neurologues que j'ai faillit être déclarer décéder, oui car quand je suis arriver a tours après avoir été héliporter en urgence vital absolue et des secours au top , dans les mains des neurochirurgien j' était en mort clinique qui a durer que quelque minutes et OUI JE SUIS ENCORE LA

MALGRES TOUT JE M' EN SUIS SORTI ALORS TOI TU PEUT AUSSI LE FAIRE , vient me voir on discutera ou appel moi 07,6388,75,41

Oldy et Sébastien



Oldy & Sébastien — de l'ombre à la lumière.

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

Reconnaître l'invisible

Il y a des souffrances qui ne se voient pas. La dépression avance masquée — derrière un sourire, un « ça va », une vie qui paraît normale.

Ce livre apprend à reconnaître l'invisible : repérer les signes chez un proche, préférer la main tendue au jugement, trouver les mots justes, et comprendre une maladie dont on guérit.

Nourri d'un vécu, c'est un livre d'entraide simple et lumineux, porté par une conviction : personne ne devrait traverser l'ombre seul — et il existe toujours un chemin vers la lumière.

En cas de souffrance : 3114

Prévention du suicide — gratuit, 24 h/24, 7 j/7.

Collection « Oldy et Sébastien »

TRIBET Sébastien